



МЕЖДУНАРОДНАЯ
АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ
ПСИХОЛОГИИ

Гиперфокус при СДВГ

Понимание и работа в КПТ

Психиатрия для психологов



Психиатрия для психологов

СДВГ связан с трудностями регуляции внимания в соответствии с текущими целями и требованиями ситуации.

Человек может испытывать трудности:

- направить внимание на нужную задачу;
- удерживать его на недостаточно стимулирующей задаче;
- сопротивляться более привлекательным стимулам;
- распределять внимание между несколькими требованиями;
- заметить необходимость переключения;
- **прекратить интересную деятельность и переключиться на другую.**

Последний пункт особенно важен для понимания гиперфокуса.

Современные исследования действительно находят связь выраженности гиперфокуса с СДВГ-чертами.

Проблема при СДВГ — не количество внимания. Проблема — управление вниманием.



Психиатрия для психологов

Что называют гиперфокусом

Единого общепринятого клинического определения пока нет, и гиперфокус не является диагностическим критерием СДВГ.

В исследованиях его обычно описывают как состояние **интенсивного и продолжительного погружения в деятельность**, сопровождающееся снижением чувствительности к другим стимулам и трудностями переключения.

В Adult Hyperfocus Questionnaire выделяются характерные компоненты:

- интенсивная концентрация;
- сильная поглощённость деятельностью;
- потеря ощущения времени;
- снижение внимания к окружающему;
- игнорирование телесных потребностей;
- трудность прекращения деятельности и переключения;
- иногда — застревание на деталях.



Психиатрия для психологов

Например: «Я решил на десять минут посмотреть информацию о новом ноутбуке. Через четыре часа обнаружил, что прочитал сравнение систем охлаждения двадцати моделей, не поел, не ответил клиенту и опоздал на встречу».

Человек потерял управление поведением относительно своих более широких целей.



Психиатрия для психологов

Гиперфокус ≠ хорошая концентрация

Это принципиальное различие. Человек может долго работать над задачей — и это совершенно не обязательно проблема.

Полезно смотреть не столько на **интенсивность концентрации**, сколько на её **управляемость**.

Продуктивная концентрация	Дисфункциональный гиперфокус
Я выбрал задачу	Я «провалился» в задачу
Могу остановиться	Очень трудно остановиться
Замечаю время	Теряю ощущение времени
Реагирую на важные сигналы	Игнорирую их
Могу изменить приоритет	Продолжаю несмотря на последствия
Учитываю сон, еду, встречи	Остальные потребности исчезают
Деятельность соответствует цели	Деятельность может вытеснить более важные цели



Психиатрия для психологов

Поэтому терапевтическая цель: **не убрать способность глубоко концентрироваться. А увеличить произвольность управления концентрацией.**



Психиатрия для психологов

Гиперфокус и flow — не одно и то же

Пересечение есть.

И там, и там возможны:

- глубокое погружение;
- высокая концентрация;
- изменение субъективного ощущения времени;
- удовольствие от деятельности.

Для практической работы удобно различать их функционально.

При flow: **«Я глубоко погружён в деятельность».**

При проблемном гиперфокусе: **«Мне трудно перестать быть погружённым в деятельность, даже когда это уже противоречит другим моим целям».**

Ключевой вопрос: Что происходит, когда появляется необходимость остановиться?



Психиатрия для психологов

Почему некоторые задачи особенно легко захватывают внимание

Здесь полезнее отказаться от идеи: **интересное → гиперфокус.**

Точнее рассматривать набор характеристик задачи.

Особенно «липкими» могут становиться активности, в которых есть сочетание: **интерес + новизна + быстрая обратная связь + частое подкрепление + ясная ближайшая цель + возможность немедленного действия.**

Например: игры; социальные сети; поиск информации; кодинг; монтаж; рисование; покупки; новое хобби; решение сложной профессиональной задачи; написание текста, если человек наконец «поймал волну».

В них часто не нужно долго ждать подкрепления.

Действие → результат → следующее действие → новый результат.

Получается плотная цепочка подкреплений.



Психиатрия для психологов

Поведенческая модель гиперфокуса

Можно рассматривать эпизод через ABC-анализ.

A — Antecedents

Что предшествует погружению?

Например:

- усталость;
- скучная задача;
- необходимость начать неприятную работу;
- появление интересного стимула;
- телефон рядом;
- открытый YouTube;
- новая идея;
- незавершённая интересная задача;
- стресс;
- отсутствие внешней структуры;
- свободный вечер.



Психиатрия для психологов

B — Behavior

Человек начинает деятельность.

И постепенно происходит: **контакт со стимулом → вовлечение → сужение внимания → продолжение → снижение реакции на альтернативные стимулы → трудность выхода.**

C — Consequences

Немедленные последствия:

- удовольствие;
- интерес;
- снижение скуки;
- чувство компетентности;
- ощущение прогресса;
- облегчение;
- избегание неприятной задачи.

Отсроченные:

- пропущенная еда;
- поздний сон;
- сорванные планы;
- невыполненная работа;
- конфликт;
- чувство вины;
- аврал.

И здесь возникает классическая поведенческая проблема: **немедленное подкрепление сильное, а негативные последствия отсрочены.**



Психиатрия для психологов

Иногда гиперфокус поддерживается избеганием

Представим:

Нужно заполнить налоговую декларацию.

Человек открывает компьютер.

Замечает интересную статью.

Начинает читать.

Потом открывает ещё одну.

Через два часа – гиперфокус.

Но функциональный анализ может показать: **требование → дискомфорт/скука/неуверенность → привлекательная деятельность → немедленное облегчение.**

То есть деятельность подкрепляется не только интересом.

Она может работать как **негативное подкрепление: интересная деятельность позволяет временно не контактировать с неприятной задачей.**

Тогда бессмысленно лечить только «залипание».

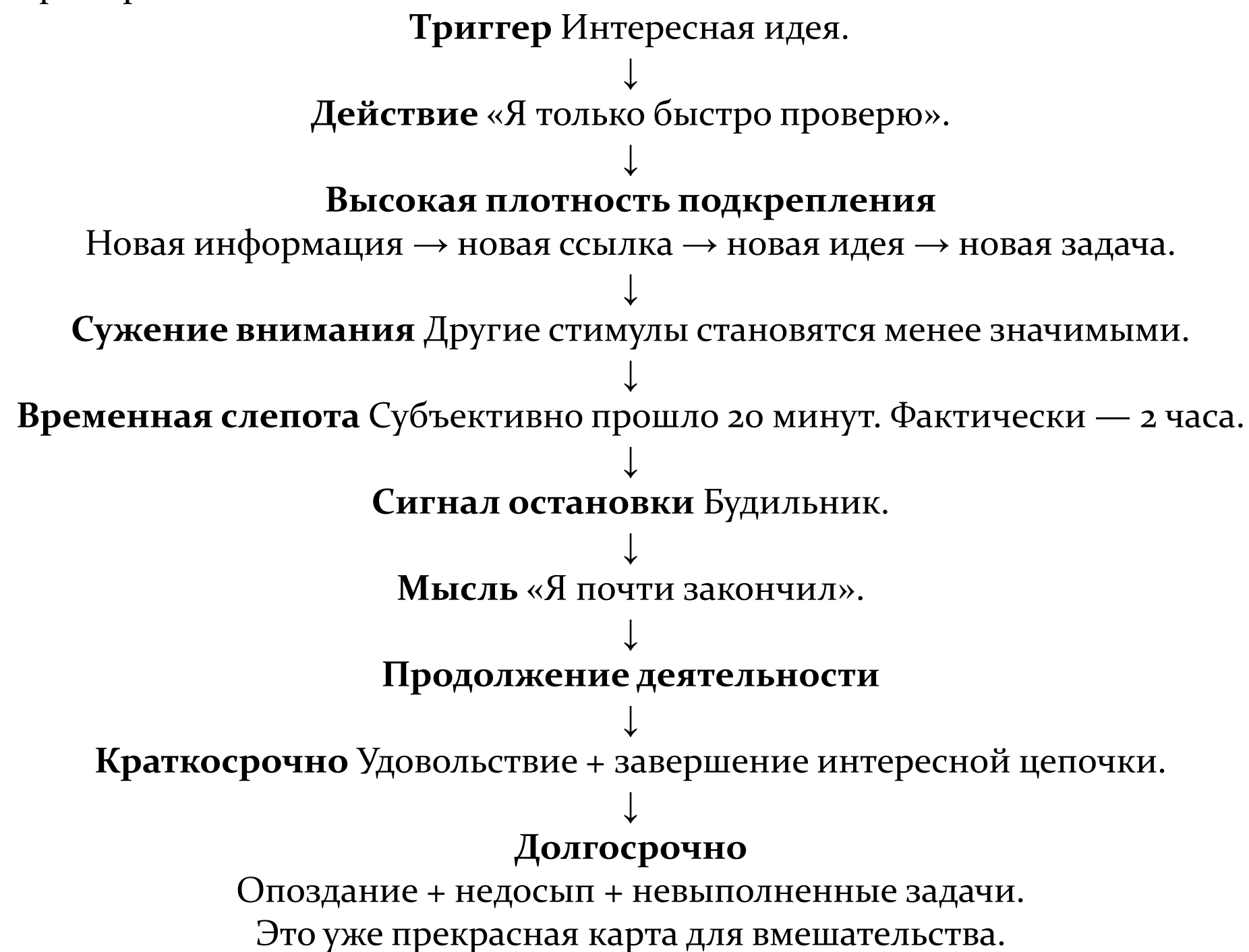
Нужно работать ещё и с: избеганием; трудностью начала; фрустрацией; неопределённостью; перфекционизмом; размером задачи.



Психиатрия для психологов

Формулировка случая

Для каждого клиента можно построить собственную модель.
Например:





Психиатрия для психологов

Что мы оцениваем

До

- Что чаще всего запускает гиперфокус?
- Какие деятельности особенно «затягивают»?
- Когда это происходит чаще?
- Есть ли связь с усталостью, скукой, стрессом?
- Что человек должен был делать вместо этого?

Во время

- Когда человек обычно впервые замечает, что «залип»?
- Замечает ли течение времени?
- Замечает ли голод, туалет, усталость?
- Что происходит при внешнем прерывании?
- Что происходит при звонке таймера?
- Какая мысль заставляет продолжать?

После

- Что было потеряно?
- Каковы последствия?
- Было ли погружение полезным?
- Соответствовало ли оно целям?
- Возникают ли вина и самокритика?



Психиатрия для психологов

Не всякий гиперфокус требует вмешательства

Например, человек говорит: «По воскресеньям я могу четыре часа рисовать и вообще ничего вокруг не замечать».

Следующий вопрос: **И это вам мешает?**

Если:

- человек выделил время;
- базовые потребности не страдают;
- обязательства не нарушаются;
- деятельность соответствует его ценностям;
- он способен остановиться при необходимости,

то превращать это в симптом не нужно.



Психиатрия для психологов

Терапевтическая цель

«Научиться выбирать, когда глубокое погружение полезно, и иметь возможность выйти из него, когда изменились приоритеты».

Можно даже дать клиенту три параметра: **Вход** → **удержание** → **выход**.

Мы хотим увеличить контроль над всеми тремя.



Психиатрия для психологов

Интервенция №1. Управляем входом

Остановить гиперфокус через три часа обычно гораздо сложнее, чем **не запускать его в неподходящий момент.**

Поэтому иногда самая эффективная интервенция: **Не начинать «липкую» деятельность перед обязательством.**

Например: встреча через 40 минут.

Клиент знает: «Если сейчас открою игру, выйти через 30 минут практически невозможно».

Решение: **игра не начинается.**

Это контроль стимулов.



Психиатрия для психологов

Создаём зоны риска

С клиентом можно классифицировать активности.

Низкий риск

Легко начать и остановить.

Средний риск

Иногда затягивает.

Высокий риск

После начала вероятность своевременной остановки резко падает.

TikTok — высокий риск.

Wikipedia — высокий.

Монтаж видео — высокий.

Уборка — средний.

Ответ на письмо — низкий.

Дальше задача становится конкретной: **не «контролировать себя», а учитывать свойства конкретной деятельности при планировании.**



Психиатрия для психологов

Интервенция №2. Создаём внешний конец деятельности

У многих задач естественного конца нет.

Особенно:

- соцсети;
- YouTube;
- поиск информации;
- игры;
- интернет-магазины;
- исследование темы.

Поэтому конец приходится **конструировать искусственно.**

Чем менее определён конец, тем легче продолжать деятельность бесконечно.



Психиатрия для психологов

Интервенция №3. Не один таймер, а система выхода

Можно использовать последовательность сигналов.
Например: **T-15 минут** - Скоро заканчиваем.

T-5 Заканчиваем текущий кусок. Новое не начинаем.

T-0 Остановка.

Первый сигнал не требует прекращения.
Он запускает **процесс завершения**.



Психиатрия для психологов

Правило «не начинай новую петлю»

Очень полезная поведенческая инструкция.

После первого сигнала: **не начинать новую единицу деятельности.**

Не открывать:

- новую статью;
- новый матч;
- новое видео;
- новый раздел;
- новую задачу;
- новую ветку исследования.

Разрешается только завершить текущую.

Таким образом мы уменьшаем количество новых цепочек подкрепления перед переключением.



Психиатрия для психологов

Интервенция №4. Планируем не остановку, а переключение

Частая ошибка: «В 19:00 перестать работать».

Мозгу предлагается: **делать что-то → ничего.**

Гораздо эффективнее:

19:00 — закончить работу.

19:05 — поставить ноутбук на зарядку.

19:10 — пойти на кухню и поесть.

То есть:

A → B, а не A → пустота.

Переключение легче, если следующая деятельность заранее определена и имеет низкий порог входа.



Психиатрия для психологов

Ритуал выхода

Можно создать стабильный поведенческий ритуал выхода.

Например: **сохранить → записать следующий шаг → закрыть программу → встать → вода → следующая задача.**

Повторяемость важна.

Со временем сама последовательность становится сигналом: **эта деятельность закончилась.**



Психиатрия для психологов

«Записать следующий шаг» — критически важная техника

Иногда человек не хочет прекращать работу потому, что боится: «Я потеряю мысль». «Завтра опять придётся полчаса вспоминать, где я остановился».

Например:

Остановилась на слайде 17.

Следующий шаг: добавить пример негативного подкрепления.

Источник открыт во второй вкладке.

Теперь прекращение работы не означает потерю контекста.



Психиатрия для психологов

Интервенция №5. Увеличиваем стоимость продолжения

Контроль стимулов может работать и на выход.

Например: таймер звонит не на компьютере, а в другой комнате.
Чтобы выключить его, нужно: **встать → отойти от рабочего места.**

Это важно, потому что само физическое изменение контекста облегчает разрыв текущей поведенческой цепочки.

Другие варианты:

- автоматическое закрытие приложения;
- блокировщик сайта;
- выключение света;
- умная розетка;
- автоматическое выключение Wi-Fi;
- внешний человек, напоминающий о переходе.

Смысл не в наказании. Мы **меняем архитектуру среды.**



Психиатрия для психологов

Интервенция №6. Работаем с когнициями, поддерживающими продолжение

«Ещё пять минут».

«Я почти закончил».

«Нельзя останавливаться посередине».

«Пока идёт вдохновение, надо использовать его полностью».

«Потом я уже не смогу так сосредоточиться».

«Если сейчас остановлюсь, всё потеряю».

Здесь полезен стандартный КПТ-вопрос:

Что вы предсказываете, если остановитесь сейчас?

А дальше — поведенческий эксперимент.



Психиатрия для психологов

Поведенческий эксперимент

Убеждение: «Если я остановлюсь, пока идёт поток, завтра я не смогу продолжить»

Эксперимент: в течение недели несколько раз сознательно остановиться в момент хорошей концентрации.

Перед остановкой:

1. записать, где остановился;
2. записать следующий конкретный шаг;
3. сохранить необходимые материалы.

На следующий день измерить:

- время возвращения в задачу;
- субъективную трудность;
- качество работы.



Психиатрия для психологов

Интервенция №7. Планируем гиперфокус

Иногда вместо борьбы полезнее использовать его как ресурс.

Если человек знает: «Когда я занимаюсь дизайном, я могу работать три часа без перерыва»,

можно выделить: **protected hyperfocus block**.

Например: 14:00–17:00.

Но перед ним проверяем:

- нет ли встречи;
- поел ли человек;
- есть ли вода;
- определён ли конец;
- что происходит после блока.

То есть глубокая концентрация становится **запланированным поведением**, а не случайным захватом дня.



Психиатрия для психологов

Гиперфокус как проблема управления подкреплением

У человека есть: **Задача А**

Отчёт.

Подкрепление:

через несколько часов.

Стоимость: скука + усилие + неопределённость.

Задача В

YouTube.

Подкрепление:

через 3 секунды.

Стоимость: минимальная.

После этого вопрос: «Почему мозг выбрал YouTube?» становится гораздо менее загадочным.



Психиатрия для психологов

Поэтому недостаточно запрещать привлекательные активности

Нужно одновременно делать менее привлекательную задачу: **короче + конкретнее + доступнее + быстрее подкрепляемой.**

Вместо: «Написать статью».

Сделать: открыть документ → написать три подзаголовка.

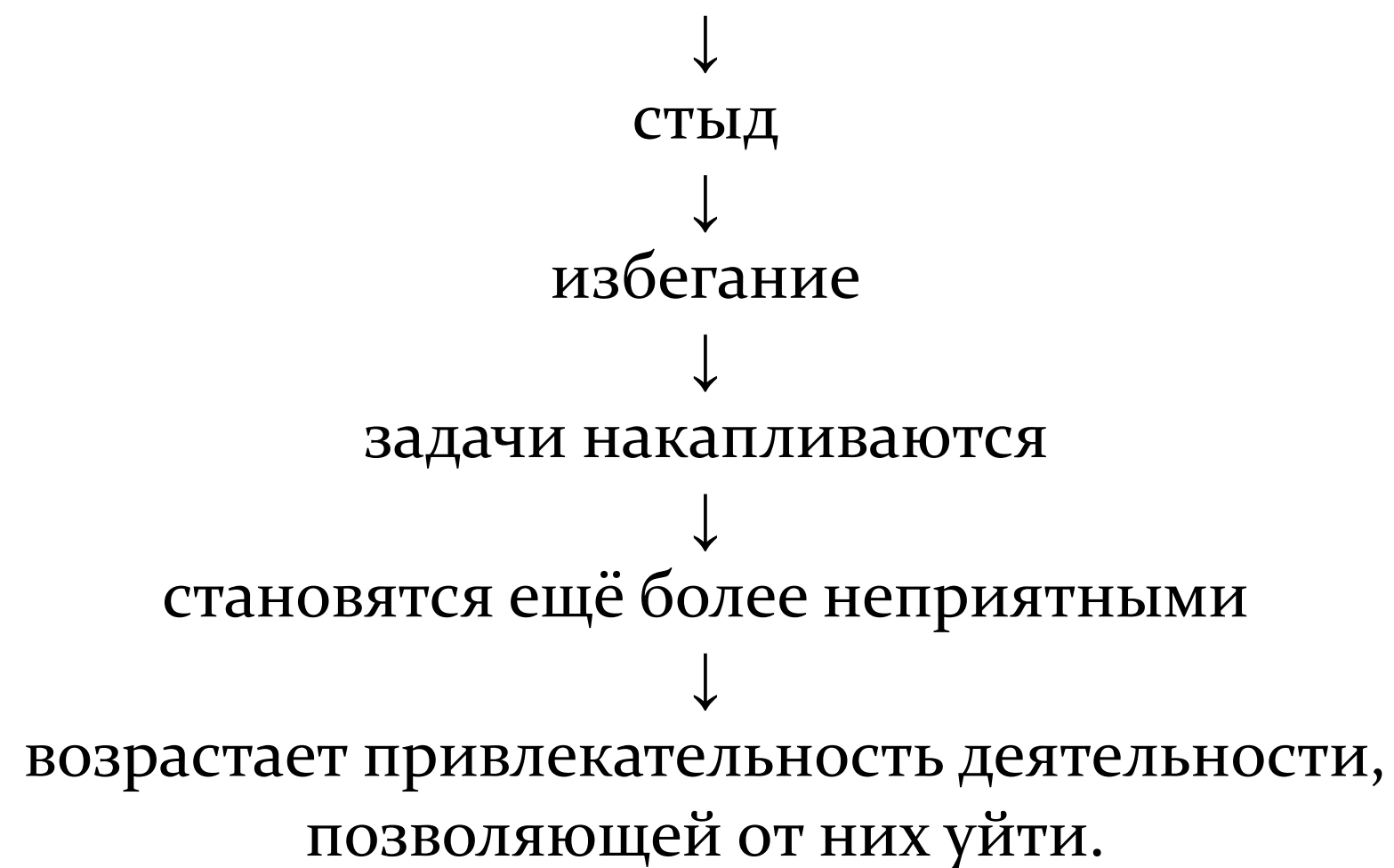
Это уже классическая поведенческая работа с СДВГ.



Психиатрия для психологов

Работа с самокритикой

После гиперфокуса часто возникает: «Я опять просрал весь день».





Психиатрия для психологов

Получается цикл: **гиперфокус → последствия → самокритика → негативный аффект → избегание → гиперфокус.**

Поэтому когнитивная работа здесь вполне оправданна.

Для перехода от глобальной оценки личности: «Я безответственный».

к функциональной: «Я начал высокорисковую деятельность за час до дедлайна и не создал условий для переключения».



Психиатрия для психологов

Практическая схема для клиента

Можно дать буквально такой алгоритм:

Шаг 1. Заметь паттерн

На чём я чаще всего залипаю?

Шаг 2. Найди условия

Когда это происходит чаще всего?

Шаг 3. Определи цену

Что гиперфокус вытесняет?

Шаг 4. Реши, нужен ли контроль входа

Стоит ли вообще начинать эту деятельность сейчас?

Шаг 5. Определи конец заранее

Не «немного», а конкретный критерий.

Шаг 6. Создай внешний сигнал

Время не должно существовать только «в голове».

Шаг 7. Создай процедуру выхода

**сигнал → закончить текущий элемент → записать
следующий шаг → физически выйти из контекста.**

Шаг 8. Определи следующую деятельность

Куда именно я переключаюсь?



Психиатрия для психологов

Поведенческий дневник гиперфокуса

Ситуация	На чём залип	Планировал	Фактически	Что удерживало	Что потерял	Как вышел
После работы	YouTube	20 мин	2 ч	«ещё одно видео»	сон	муж напомнил
Подготовка лекции	поиск статей	30 мин	3 ч	интересно + «надо разобраться полностью»	сама презентация	устала
Выходной	игра	2 ч	3 ч	удовольствие	ничего	закончила матч